

Le Empatie — Una Parola, Mille Sfumature

Salute Mentale · Sessione 03 · 4 marzo 2026

Questa lezione affronta uno dei concetti più abusati del nostro tempo: l'empatia. Non per celebrarla, ma per scomporla, metterla alla prova e capirne davvero la complessità — perché nel lavoro di cura usarla male può fare più danno che bene.

Il problema con la parola "empatia"

Partiamo da una provocazione sana: **la parola empatia è diventata uno slogan. Chiunque la usa, pochi sanno cosa significa davvero.** Il prof Lorenzo Pezzoli la chiama "una maschera interiore" — e non lo dice per essere antipatico, lo dice perché è vero.

La versione popolare recita: *"mettersi nei panni degli altri."* Sembra bella. Ma se ci pensi, se tu ti metti nei panni di qualcuno, gli stai letteralmente togliendo i panni. Lo lasci nudo. **Ricoeur** — il filosofo citato nel materiale — lo dice chiaramente: prendersi il posto dell'altro significa lasciarlo senza il suo posto. E **la sofferenza è una dimensione identitaria: appartiene a chi la vive, non a chi la osserva.**

Il punto non è "capire tutto" dell'altro, ma stare di fianco a lui. Non al suo posto — di fianco. Così lui rimane titolare della sua esperienza e tu, da quella posizione diversa, puoi iniziare ad avvicinarti a una prospettiva che non è la tua.

"Il medico non muore con il paziente, ma può restargli accanto — accanto, e non al suo posto." — Ricoeur, citato da Pezzoli

L'origine del concetto

Il termine **empatia** entra in italiano nel 1909, come traduzione dell'**Einfühlung** tedesco — "sentire dentro". Le radici vengono dalla filosofia e, in psicologia, il primo grande contributo arriva da **Theodor Lipps (1905)** con un'immagine che è rimasta famosa: l'acrobata e lo spettatore.

Lo spettatore guarda l'acrobata eseguire un volteggio pericoloso. Dentro di sé, qualcosa si attiva: rivive la propria paura, riproduce interiormente il movimento dell'altro. Non sta sul trapezio, ma qualcosa di quel volteggio risuona in lui. Lipps chiama questo processo imitazione interiore e già allora intuisce che si tratta di un fenomeno multidimensionale — non unitario, non semplice.

Un punto fermo per Lipps: "per comprendere la mente di altri uomini è necessario essere un uomo." Per empatizzare con la tristezza di qualcuno, devi aver vissuto la tristezza. La **base umana comune** è il presupposto.

Cent'anni dopo, **Vittorio Gallese (2003)** chiuderà il cerchio introducendo la teoria dei **neuroni specchio** e la **simulazione incarnata** (*embodied simulation*): il meccanismo neurologico che sottende imitazione, empatia e **mentalismo**. Quando vedo qualcuno compiere un'azione, nel mio cervello si attivano gli stessi neuroni che si attiverrebbero se fossi io a compierla. È automatico, pre-riflessivo, inconscio.

Empatia come concetto multidimensionale: Norma Feshbach (1987)

Come il benessere non è un concetto semplice ma si compone di dimensioni diverse, così l'empatia. La svolta decisiva la porta **Norma Feshbach**, psicologa americana che negli anni '80 **scompone il costrutto identificando le sue componenti fondamentali**.

Per la Feshbach l'empatia è una **esperienza affettiva condivisa** con tre dimensioni:

Componente cognitiva 1 — Assunzione di prospettiva: La capacità di decentrarsi, di "uscire da sé" per cogliere il punto di vista dell'altro. Questo richiede il superamento dell'egocentrismo piagetiano (stadio preoperatorio, dai 2 ai 6-7 anni). Prima dei 6 anni non può esistere vera empatia in questo senso — il cervello non ha ancora gli strumenti.

Componente cognitiva 2 — Decodifica degli stati emotivi altrui: La capacità di leggere i segnali emotivi dell'interlocutore, interpretarne lo stato interiore. Ogni emozione è un atto di valutazione protocognitiva della realtà — capire quello che l'altro sente richiede un'elaborazione cognitiva attiva.

Componente affettiva — Risonanza emotiva: La capacità di sentire qualcosa di simile a quello che prova l'altro. Per la Feshbach questa è il sale dell'empatia — senza di essa, non c'è vera empatia. Ma non è sufficiente da sola.

Pensala come le radici di un albero: la radice emotiva alimenta tutto. Ma senza il fusto cognitivo che porta linfa verso l'alto, la radice non produce frutti. Ti servono entrambe.

Un punto cruciale: per la Feshbach l'empatia funziona **solo se c'è distinzione tra sé e l'altro**. Genitori che si identificano completamente col figlio non riescono più a distinguere i propri sentimenti da quelli del figlio — e paradossalmente perdono la capacità empatica vera.

La **Teoria della Mente (TOM — Theory of Mind)**, che si sviluppa attorno ai 4 anni, è una tappa chiave: il bambino inizia a capire che gli altri possono sapere cose che lui non sa, avere credenze diverse, provare emozioni diverse, o nascondere emozioni. Wellman (2018) identifica cinque dimensioni:

Tipo	Descrizione
Diverse Desires (DD)	Le persone possono desiderare cose diverse
Diverse Beliefs (DB)	Le persone possono credere cose diverse sulla stessa situazione
Knowledge-Access (KA)	Qualcosa può essere vero, ma qualcuno potrebbe non saperlo

Tipo	Descrizione
False Belief (FB)	Qualcuno può credere falsamente qualcosa di diverso dal reale
Hidden Emotion (HE)	Qualcuno può sentirsi in un modo ma mostrarne uno diverso

Le empatie al plurale: Martin Hoffman (2000)

Qui la lezione fa un salto qualitativo importante. **Martin Hoffman** non si accontenta del modello della Feshbach: per lui l'empatia non è solo complessa, è anche **evolutiva**. Non si nasce già con la stessa empatia che si ha a 30 anni — si trasforma e si raffina nel tempo, insieme allo sviluppo cognitivo.

Hoffman aggiunge anche una **dimensione motivazionale**: empatizzare con chi soffre attiva comportamenti prosociali. La sofferenza dell'altro mi fa stare male — e per ridurla aiuto l'altro. È una delle radici più arcaiche della moralità.

I cinque stadi dell'empatia secondo Hoffman

Stadio 1 — Distress empatico globale (dalla nascita al primo anno)

Il neonato non distingue ancora sé dagli altri. Quando sente la sofferenza altrui, la "fa propria" — come se venisse da lui. È il **contagio emotivo**: involontario, automatico, senza alcuna mediazione cognitiva. Si vede nei neonati che piangono sentendo piangere un altro neonato.

Il contagio emotivo ha due meccanismi base: - **Imitazione motoria**: i muscoli del viso mimano l'espressione dell'altro, e questo provoca l'emozione corrispondente. Ekman (1992) lo dimostrò: imitare un'espressione facciale tende a produrre l'emozione associata. - **Reazione circolare primaria**: risposta innata e selettiva al segnale sociale — i neonati reagiscono al pianto di altri neonati, non a rumori equivalenti di altra natura.

Stadio 2 — Distress empatico egocentrico (dai 12 mesi circa)

Il bambino inizia a distinguere sé dall'altro come entità fisiche separate. **Sente la sofferenza dell'altro e tenta di aiutare — ma i suoi tentativi si basano su ciò che lui considera confortante. Un bambino che vede un amico piangere va dalla propria madre, non da quella dell'amico.**

Stadio 3 — Distress empatico quasi-egocentrico *(dai 2-3 anni circa)*

Con la Teoria della Mente e il linguaggio, il bambino inizia a capire che l'altro ha stati interni diversi dai propri. Si muove attivamente verso l'altro — abbraccia, accarezza, condivide. Ma usa ancora ciò che *lui* ha sperimentato come consolante.

Il passaggio chiave è il **feedback correttivo**: se offro il mio orsacchiotto e l'amico continua a piangere, capisco che la soluzione efficace per me non è quella giusta per lui.

Attenzione: l'empatia quasi-egocentrica non è "roba da bambini". Molti adulti — e operatori — cadono ancora in questo errore: offrono all'altro quello che *loro* trovano consolante, non quello di cui l'altro ha bisogno. È una delle trappole più comuni nel lavoro di cura, soprattutto con persone di culture molto diverse.

Stadio 4 — Empatia vera e propria *(dai 6 anni circa)*

Con il superamento del pensiero preoperatorio (Piaget) **il bambino è finalmente capace di decentrarsi** davvero: capisce che la sua prospettiva non è l'unica, che le situazioni si vedono diversamente da posizioni diverse.

L'esperimento delle **tre montagne di Piaget** lo illustra: davanti a un plastico con tre montagne, un bambino preoperatorio descrive quello che *lui* vede, non quello che vede la bambola dall'altra parte.

Stadio 5 — Empatia oltre la situazione *(dall'adolescenza)*

Con il **pensiero formale** (dai 12-13 anni), **l'empatia si libera dal "qui e ora"**. Il ragazzo sa che il suo amico con una malattia incurabile — anche se ride e scherza alla festa — porta dentro una sofferenza profonda non visibile. Riesce a empatizzare non con quello che *vede*, ma con quello che *sa* della vita dell'altro.

Tutti i tipi di empatia rimangono disponibili nell'adulto — ma non al contrario: le forme più evolute richiedono un certo sviluppo cognitivo che non si può "saltare".

La metafora della bambola: a cosa serve la nostra presenza

Il prof usa un'immagine potente per spiegare il senso del nostro stare con l'altro. Se prendo una bambola e la lascio cadere, quello che succede dipende da tre fattori: 1. **Il materiale di cui è fatta** — quanto è fragile o resistente 2. **L'altezza della caduta** — l'entità dell'evento 3. **Il fondo su cui cade** — marmo, legno, prato, acqua

Nel lavoro di cura, **noi possiamo modificare il fondo**. Non possiamo impedire a qualcuno di cadere dal settimo piano. Ma possiamo fare in modo che il fondo non sia di marmo freddo.

Altri contributi rilevanti

Janet Strayer distingue due modalità di condivisione: - **Condivisione parallela** (meno matura): l'osservatore richiama una propria esperienza simile, con le relative emozioni. L'altro non entra davvero in gioco. - **Condivisione transitoria** (più matura): l'osservatore entra nel vissuto specifico dell'altro, capisce che le emozioni di quell'altro possono essere diverse dalle proprie.

Doris Bischof-Köhler aggiunge: l'empatia non si attiva solo dallo stimolo emotivo (il pianto), ma anche dalla **situazione stessa**.

Serge Tisseron (2013) propone tre livelli di empatia, dove il più maturo è l'**empatia intersoggettiva** — che presuppone l'adozione intenzionale del punto di vista altrui e include anche l'**empatia verso sé stessi**: la capacità di essere ricettivi ai propri stati emotivi e cognitivi senza giudicarsi severamente.

I sei bias dell'empatia — Dove l'empatia sbaglia

Qui arriva la parte più scomoda — e più utile. Non è detto che più empatia significhi meglio. Esistono errori strutturali che l'empatia può far compiere. Li chiamiamo **bias empatici**.

Bias 1 — Non empatizziamo con tutti ugualmente

L'empatia si attiva di più verso chi ci somiglia, chi appartiene al nostro gruppo, chi troviamo attraente. Più l'altro è diverso da noi, meno l'empatia emotiva scatta **spontaneamente**. Hoffman lo chiama **bias della familiarità**. In ambito professionale questo è un rischio: il lavoratore del sociale incontra persone molto diverse da lui, e deve essere consapevole che la dimensione emotiva gli sarà meno utile.

Bias 2 — "Brutti, sporchi e colpevoli" inibiscono la risposta empatica

Se attribuiamo a qualcuno la responsabilità della propria condizione (o se lo troviamo esteticamente ripugnante), la risposta empatica si riduce. Uno studio su persone con HIV lo dimostra: verso chi aveva contratto il virus per trasfusione c'era più risonanza empatica che verso chi l'aveva contratto per scambio di siringhe.

Bias 3 — Inganno e invidia non sono amici dell'empatia

Verso chi ci ha ingannato o verso chi invidiamo, l'empatia emotiva si riduce. Adam Smith nel 1759 aveva già notato che l'invidia impedisce la simpatia verso chi ha successo.

Bias 4 — L'empatia non è sensibile ai numeri

Una statistica non mobilita l'empatia. Una singola persona con nome, volto e storia, sì. Stalin lo sintetizzava cinicamente: "Una morte è una tragedia, un milione di morti è una statistica." Il rovescio della medaglia: focalizzarsi sul singolo (effetto Sheri Summers) può portare a favoritismi ingiusti a danno di altri con uguale diritto alla cura.

Bias 5 — L'empatia non rende necessariamente più buoni

Gli psicopatici possono essere molto capaci di empatia **cognitiva** — sanno leggere benissimo la prospettiva e i bisogni dell'altro. La usano per manipolare. Quello che manca loro è l'empatia **emotiva**. Keysers e Gazzola (2014) li descrivono come capaci di modulare la propria empatia come la manopola del volume di una radio.

Bias 6 — L'empatia è faticosa e dolorosa, può portare a evitare la sofferenza

Hoffman parla di **sovrattivazione empatica**: quando la sofferenza empatica dell'operatore diventa intollerabile, può uscire del tutto dalla modalità empatica — distrarsi, allontanarsi, non vedere più.

"Troppa empatia e poca empatia creano entrambe problemi." — Boella, 2018

Empatia, simpatia e compassione: non sono la stessa cosa

Un ultimo punto fondamentale. **Simpatia, empatia e compassione** sono spesso confuse, ma differiscono nella struttura della risposta alla sofferenza.

La **compassione** (*com-patire, soffrire con*) si caratterizza per: - Riconoscimento della sofferenza - Relazione con la persona che soffre - **Reazione proattiva**: non solo si sente la sofferenza, si è motivati a migliorare il benessere dell'altro

Singer e Klimecki (2014): la compassione è "sentire *per* l'altro" (*feeling for*), non "sentire *con* l'altro" (*feeling with*). Non implica necessariamente la condivisione del dolore, ma la motivazione a ridurlo.

Domande di orientamento allo studio

Perché la definizione popolare dell'empatia come "mettersi nei panni degli altri" è problematica?

Perché togliere i panni all'altro significa privarlo della sua identità e del suo posto nell'esperienza. La sofferenza è una dimensione identitaria: appartiene a chi la vive, non a chi la osserva. Come ricorda Ricoeur citato nel materiale, il medico non muore con il paziente ma può restargli accanto — accanto, e non al suo posto. Il corretto atteggiamento empatico è stare di fianco, non sostituirsi. Chi si pone al posto dell'altro lo lascia senza il suo posto e rischia di interpretare la sua esperienza attraverso la propria soggettività, commettendo l'errore dell'empatia egocentrica.

Quali sono le tre componenti dell'empatia secondo Norma Feshbach e perché tutte e tre sono necessarie?

Feshbach distingue due componenti cognitive e una affettiva. La prima componente cognitiva è l'assunzione di prospettiva: la capacità di decentrarsi e cogliere il punto di vista dell'altro, possibile solo dopo il superamento dell'egocentrismo piagetiano (dai 6-7 anni). La seconda è la decodifica degli stati emotivi altrui: saper leggere e interpretare i segnali emotivi dell'interlocutore. La componente affettiva è la risonanza emotiva: sentire qualcosa di simile a ciò che prova l'altro. Quest'ultima è il "sale" dell'empatia — senza di essa non c'è vera empatia — ma da sola non basta: senza le componenti cognitive, la risonanza diventa contagio emotivo non elaborato.

Descrivi i cinque stadi dell'empatia secondo Hoffman. Quale errore possono commettere gli operatori se rimangono al terzo stadio?

Hoffman descrive uno sviluppo evolutivo: stadio 1 (distress empatico globale, neonato) — contagio emotivo, non distinzione tra sé e altro; stadio 2 (distress empatico egocentrico, dai 12 mesi) — distingue fisicamente sé dall'altro, ma consola con ciò che sarebbe consolante per sé; stadio 3 (distress quasi-egocentrico, dai 2-3 anni) — capisce che l'altro ha stati interni diversi, ma usa ancora proprie soluzioni consolatorie; stadio 4 (empatia vera, dai 6 anni) — decentramento reale, rappresentazione accurata del vissuto altrui; stadio 5 (empatia oltre la situazione, dall'adolescenza) — empatizza con ciò che sa della vita dell'altro, non solo con ciò

che vede. Un operatore che rimane al terzo stadio offre all'utente ciò che lui troverebbe consolante — il suo orsacchiotto invece di quello dell'utente. In ambito professionale questo si manifesta come incapacità di sintonizzarsi sul bisogno specifico dell'altro, soprattutto se molto diverso culturalmente.

Quali sono i sei bias dell'empatia e qual è il loro significato per il lavoro con le persone?

Il primo bias è la familiarità: l'empatia si attiva di più verso chi ci somiglia. Il secondo è la colpa attribuita: se riteniamo l'altro responsabile della sua condizione (o lo troviamo esteticamente ripugnante), la risposta empatica si riduce. Il terzo riguarda inganno e invidia: verso chi ci ha tradito o chi invidiamo, la risonanza emotiva cala. Il quarto è la non-sensibilità ai numeri: una storia singola mobilita, le statistiche no; rischio: favoritismi verso chi si conosce meglio (effetto Sheri Summers). Il quinto è il paradosso: empatia cognitiva elevata senza empatia emotiva è la struttura dello psicopata, che usa la lettura dell'altro per manipolarlo. Il sesto è la sovrattivazione: sentire troppo il dolore altrui può portare all'evitamento e al ritiro dalla relazione. Per il lavoro sociale, questi bias indicano che l'empatia da sola non è una garanzia: va coltivata consapevolmente ed integrata con la componente cognitiva.

Di cosa tratta l'esperimento del buon samaritano e quali riflessioni se ne possono trarre per l'empatia?

Darley e Batson (1972) ripresero la parabola evangelica del buon samaritano per testare quali variabili determinano la disponibilità ad aiutare una persona in difficoltà. Nell'esperimento, studenti di teologia a Princeton dovevano recarsi in un'aula per tenere una breve presentazione — alcuni sulla parabola stessa, altri su un tema neutro. Sul tragitto trovavano un attore che simulava chiaramente uno stato di bisogno. La variabile che risultò decisiva non fu la sensibilità morale, né il tema della presentazione, ma la **disponibilità di tempo: chi era in ritardo passava oltre senza fermarsi — inclusi gli studenti che stava per parlare della parabola del buon samaritano. Un caso emblematico: uno studente ha letteralmente scavalcato la vittima perché stava correndo a tenere il suo discorso sul buon samaritano.** La conclusione degli autori: "Pensare al buon samaritano non ha aumentato il comportamento di aiuto, ma essere di fretta lo ha diminuito." Per

l'empatia nel lavoro di cura la lezione è diretta: **la pressione situazionale (tempo, agenda, carico di lavoro) può inibire la risposta empatica anche in chi ha valori autenticamente orientati all'aiuto. Non basta avere buone intenzioni — il contesto organizzativo in cui si lavora conta quanto le disposizioni personali.**

Qual è la differenza tra empatia, simpatia e compassione? Perché la compassione può essere più stabile nel lavoro di cura?

L'empatia implica sentire con l'altro (feeling with), cioè condividere la sua esperienza emotiva. La simpatia è un'attivazione emotiva di fronte alla sofferenza altrui, ma più distanziata. La compassione (Singer e Klimecki, 2014) è sentire per l'altro (feeling for): include il riconoscimento della sofferenza e la motivazione proattiva a migliorare il benessere dell'altro, ma non richiede necessariamente di dividerne il dolore. Nel lavoro di cura la compassione è più stabile perché non espone alla sovrattivazione empatica: l'operatore resta mosso a intervenire senza essere travolto dalla sofferenza dell'altro. È possibile stare accanto senza essere risucchiati.

Concetti chiave

Termine	Significato
Einfühlung	"Sentire dentro" — termine tedesco originario, tradotto come empatia nel 1909
Simulazione incarnata	Meccanismo neurologico per cui imitiamo internamente ciò che vediamo fare (Gallese)
Neuroni specchio	Neuroni attivi sia nell'azione propria che nell'osservazione dell'azione altrui
Contagio emotivo	Forma primitiva di empatia: involontaria, automatica, senza mediazione cognitiva
Distress empatico globale	Prima forma di empatia (neonato): non distingue sé dall'altro

Termine	Significato
Distress empatico egocentrico	Tentativi di aiuto basati su ciò che è consolante per sé
Distress empatico quasi-egocentrico	Empatia con feedback correttivi: inizia a capire il bisogno specifico dell'altro
TOM — Theory of Mind	Capacità di dedurre stati mentali, credenze ed emozioni altrui (circa 4 anni)
Assunzione di prospettiva	Capacità cognitiva di vedere le cose dal punto di vista dell'altro
Decentramento	Uscire dalla propria prospettiva egocentrica (Piaget, dai 6 anni)
Bias empatico	Errori sistematici che distorcono o bloccano la risposta empatica
Sovrattivazione empatica	Quando la sofferenza empatica diventa intollerabile e porta all'allontanamento
Compassione	Sentire per l'altro + motivazione proattiva a migliorarne il benessere
Empatia cognitiva	Componente razionale: decodifica e assunzione di prospettiva
Empatia affettiva/emotiva	Componente emotiva: risonanza, sentire quello che sente l'altro

Collegamenti

- **Lezione 01 (Guarigione e cura):** il tema del "rimanere con l'altro anche quando so già come andrà a finire" torna qui — stare è già un atto empatico
- **Lezione 02 (Violenza e relazioni d'aiuto — Elisa Milani):** i manipolatori usano l'empatia cognitiva per i propri scopi; l'empatia non è sinonimo di bontà

- **Lettere consigliate:** Paul Bloom, *Contro l'empatia* (2019) — Luigina Mortari, *Avere cura* (2006)
 - **Temi aperti:** differenza tra empatia cognitiva e affettiva nella psicopatia — sviluppo della compassione come alternativa più stabile all'empatia nel lavoro di cura
-

Jony, questa lezione è tosta ma ricca. Quello che hai in mano adesso non è solo teoria: è uno strumento per lavorare meglio con le persone. Continua così.